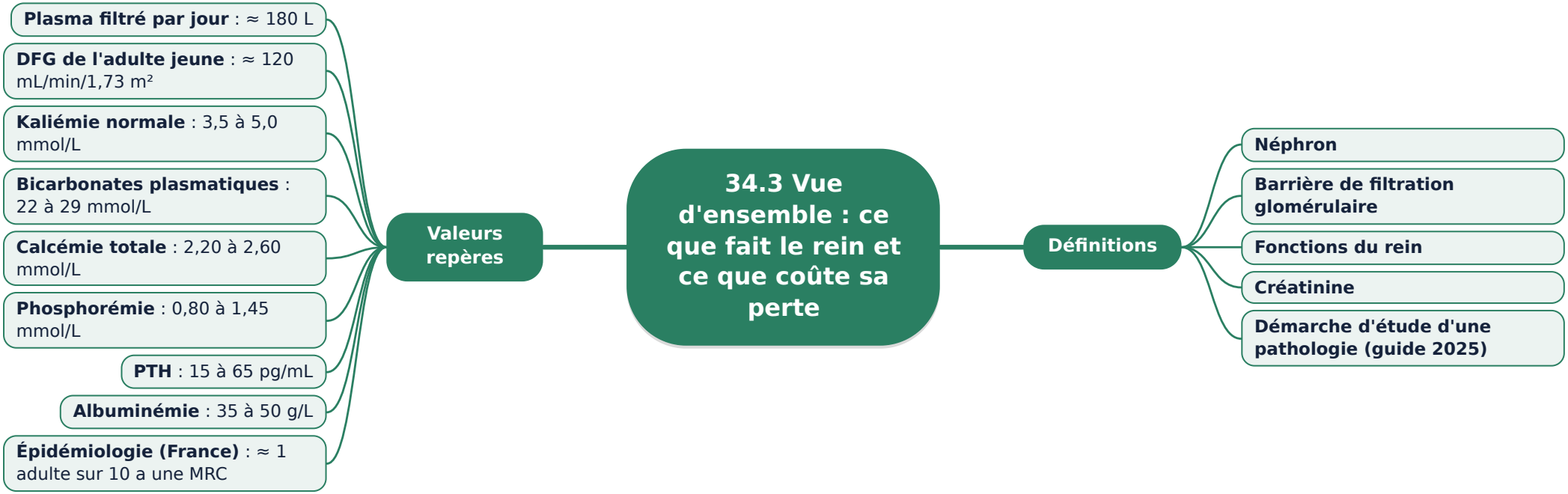
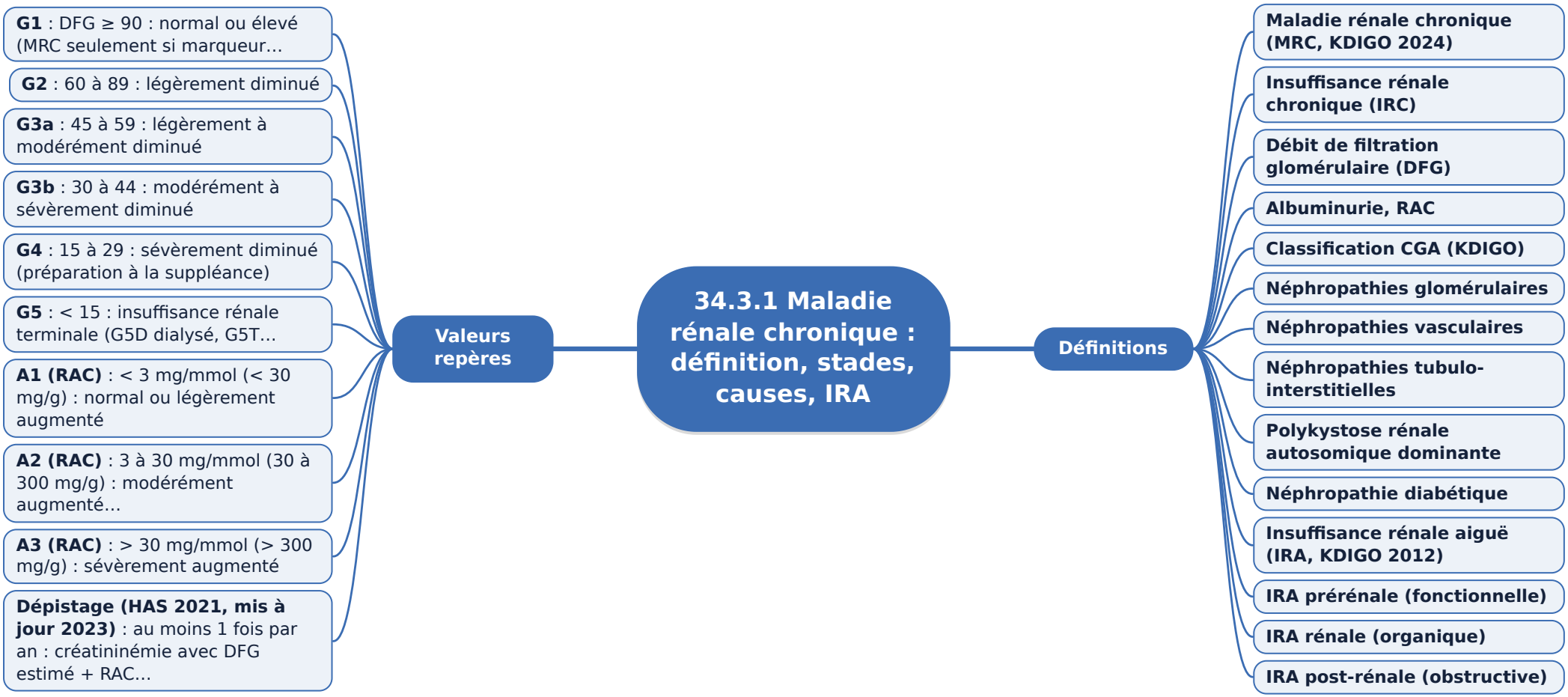
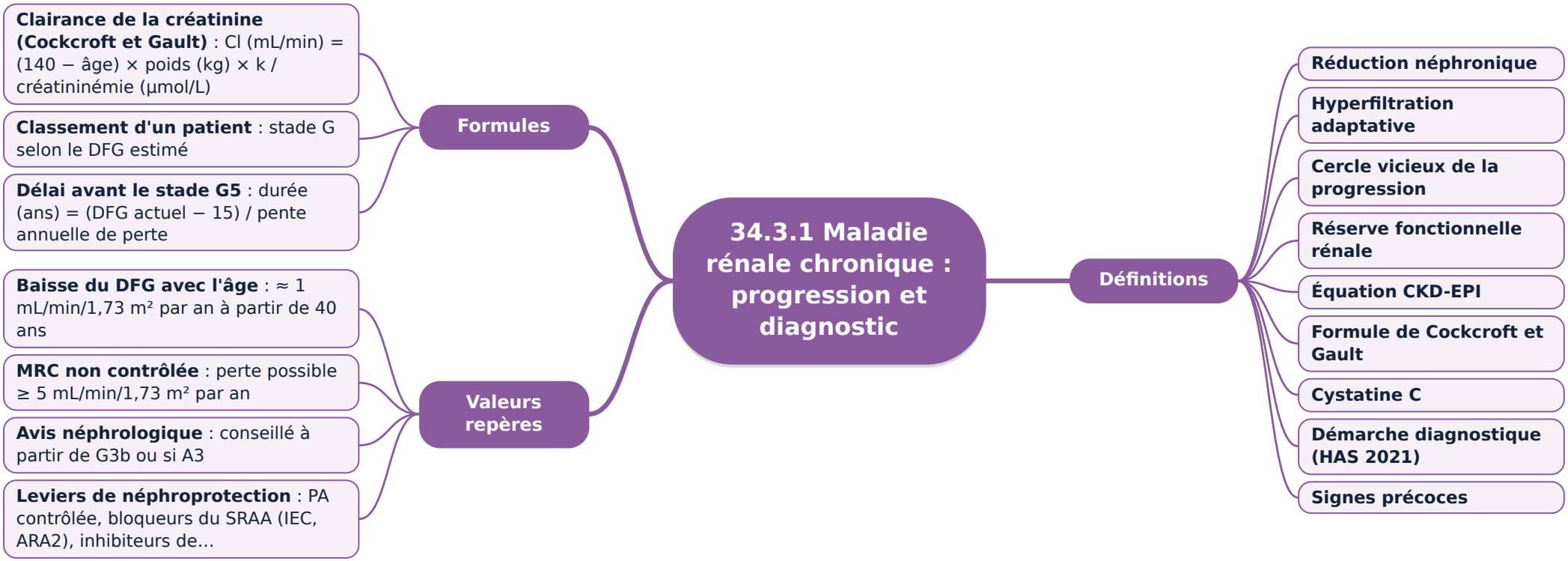

Pathologies de l'appareil urinaire
34.3.4
Syndrome néphrotique : définitions et mécanismes
34.3.4
Syndrome néphrotique : traitement et corticothérapie prolongée
34.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés
34.4.1
à 34.4.3 Potassium, phosphore caché et sel
34.4.4
à 34.4.7 Eaux, âge et médicaments, collectivité, activité physique
34.6 Situations professionnelles du diététicien
34.8 Fiches de synthèse : repères pratiques
34.9 Unités, conversions et relations
34.11 Entraînements, études de cas et sujets : calculs corrigés
34.3 Vue d'ensemble : ce que fait le rein et ce que coûte sa perte
34.3.1
Maladie rénale chronique : définition, stades, causes, IRA
34.3.1
Maladie rénale chronique : progression et diagnostic
34.3.1
Maladie rénale chronique : complications et dénutrition
34.3.1
Maladie rénale chronique : traitement et alimentation avant la dialyse
34.3.2
Dialyses : principes, hémodialyse, dialyse péritonéale
34.3.2
Alimentation du dialysé et transplantation rénale
34.3.3
Lithiase rénale : calculs, lithogenèse, facteurs de risque
34.3.3
Lithiase rénale : colique néphrétique, bilan, prévention


34.3 Vue d'ensemble : ce que fait le rein et ce que coûte sa perte
Valeurs repères
Plasma filtré par jour : ≈ 180 L
DFG de l'adulte jeune : ≈ 120 mL/min/1,73 m²
Kaliémie normale : 3,5 à 5,0 mmol/L
Bicarbonates plasmatiques : 22 à 29 mmol/L
Calcémie totale : 2,20 à 2,60 mmol/L
Phosphorémie : 0,80 à 1,45 mmol/L
PTH : 15 à 65 pg/mL
Albuminémie : 35 à 50 g/L
Épidémiologie (France) : ≈ 1 adulte sur 10 a une MRC
Définitions
Néphron
Barrière de filtration glomérulaire
Fonctions du rein
Créatinine
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)


34.3.1 Maladie rénale chronique : définition, stades, causes, IRA
Définitions
Maladie rénale chronique (MRC, KDIGO 2024)
Insuffisance rénale chronique (IRC)
Débit de filtration glomérulaire (DFG)
Albuminurie, RAC
Classification CGA (KDIGO)
Néphropathies glomérulaires
Néphropathies vasculaires
Néphropathies tubulo-interstitielles
Polykystose rénale autosomique dominante
Néphropathie diabétique
Insuffisance rénale aiguë (IRA, KDIGO 2012)
IRA prérénale (fonctionnelle)
IRA rénale (organique)
IRA post-rénale (obstructive)
Valeurs repères
G1 : DFG ≥ 90 : normal ou élevé (MRC seulement si marqueur...
G2 : 60 à 89 : légèrement diminué
G3a : 45 à 59 : légèrement à modérément diminué
G3b : 30 à 44 : modérément à sévèrement diminué
G4 : 15 à 29 : sévèrement diminué (préparation à la suppléance)
G5 : < 15 : insuffisance rénale terminale (G5D dialysé, G5T...
A1 (RAC) : < 3 mg/mmol (< 30 mg/g) : normal ou légèrement augmenté
A2 (RAC) : 3 à 30 mg/mmol (30 à 300 mg/g) : modérément augmenté...
A3 (RAC) : > 30 mg/mmol (> 300 mg/g) : sévèrement augmenté
Dépistage (HAS 2021, mis à jour 2023) : au moins 1 fois par an : créatininémie avec DFG estimé + RAC...


34.3.1 Maladie rénale chronique : progression et diagnostic
Définitions
Réduction néphronique
Hyperfiltration adaptative
Cercle vicieux de la progression
Réserve fonctionnelle rénale
Équation CKD-EPI
Formule de Cockcroft et Gault
Cystatine C
Démarche diagnostique (HAS 2021)
Signes précoces
Formules
Clairance de la créatinine (Cockcroft et Gault) : Cl (mL/min) = (140 − âge) × poids (kg) × k / créatininémie (µmol/L)
Classement d'un patient : stade G selon le DFG estimé
Délai avant le stade G5 : durée (ans) = (DFG actuel − 15) / pente annuelle de perte
Valeurs repères
Baisse du DFG avec l'âge : ≈ 1 mL/min/1,73 m² par an à partir de 40 ans
MRC non contrôlée : perte possible ≥ 5 mL/min/1,73 m² par an
Avis néphrologique : conseillé à partir de G3b ou si A3
Leviers de néphroprotection : PA contrôlée, bloqueurs du SRAA (IEC, ARA2), inhibiteurs de...

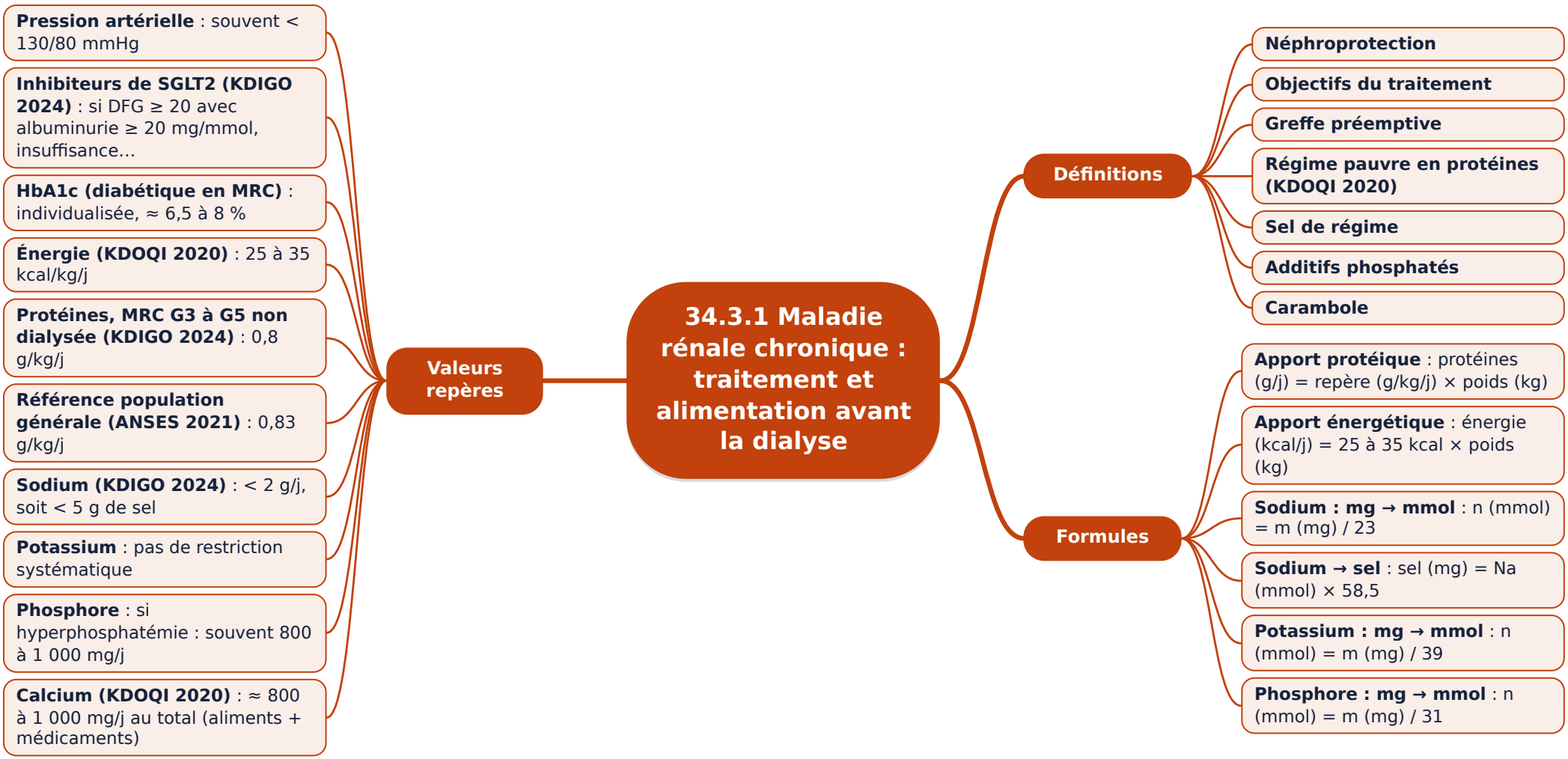
34.3.1 Maladie rénale chronique : complications et dénutrition

Définitions

- **Syndrome urémique**
- **Hyperkaliémie**
- **Acidose métabolique de la MRC**
- **Hyperparathyroïdie secondaire**
- **Troubles minéraux et osseux (TMO-MRC)**
- **Ostéodystrophie rénale**
- **Anémie de la MRC (KDIGO 2012)**
- **Syndrome de cachexie-dénutrition protéino-énergétique (PEW, ISRNM 2008)**
- **Poids sec**
- **Complication cardiovasculaire**

Valeurs repères

- **Charge acide alimentaire** : ≈ 1 mmol d'ions H^+/kg/j (surtout protéines animales...
- **Traitement de l'acidose (KDIGO 2024)** : bicarbonate de sodium au moins si bicarbonates < 18 mmol/L
- **Hb visée sous agents stimulant l'érythropoïèse (KDIGO 2012)** : 10 à 11,5 g/dL
- **Critères PEW : biologie** : albuminémie < 38 g/L...
- **Critères PEW : masse corporelle** : IMC < 23 kg/m²
- **Critères PEW : masse musculaire** : perte ≥ 5 % en 3 mois, tour de bras diminué
- **Critères PEW : apports** : protéines < 0,6 g/kg/j (avant dialyse) ou < 0,8 g/kg/j...
- **Dénutrition en dialyse** : ≈ 1 patient sur 3 (20 à 50 % selon les critères)
- **Statine** : à partir de 50 ans en MRC non dialysée (KDIGO 2013)


34.3.1 Maladie rénale chronique : traitement et alimentation avant la dialyse
Définitions
Néphroprotection
Objectifs du traitement
Greffe préemptive
Régime pauvre en protéines (KDOQI 2020)
Sel de régime
Additifs phosphatés
Carambole
Formules
Apport protéique : protéines (g/j) = repère (g/kg/j) × poids (kg)
Apport énergétique : énergie (kcal/j) = 25 à 35 kcal × poids (kg)
Sodium : mg → mmol : n (mmol) = m (mg) / 23
Sodium → sel : sel (mg) = Na (mmol) × 58,5
Potassium : mg → mmol : n (mmol) = m (mg) / 39
Phosphore : mg → mmol : n (mmol) = m (mg) / 31
Valeurs repères
Pression artérielle : souvent < 130/80 mmHg
Inhibiteurs de SGLT2 (KDIGO 2024) : si DFG ≥ 20 avec albuminurie ≥ 20 mg/mmol, insuffisance...
HbA1c (diabétique en MRC) : individualisée, ≈ 6,5 à 8 %
Énergie (KDOQI 2020) : 25 à 35 kcal/kg/j
Protéines, MRC G3 à G5 non dialysée (KDIGO 2024) : 0,8 g/kg/j
Référence population générale (ANSES 2021) : 0,83 g/kg/j
Sodium (KDIGO 2024) : < 2 g/j, soit < 5 g de sel
Potassium : pas de restriction systématique
Phosphore : si hyperphosphatémie : souvent 800 à 1 000 mg/j
Calcium (KDOQI 2020) : ≈ 800 à 1 000 mg/j au total (aliments + médicaments)

34.3.2 Dialyses : principes, hémodialyse, dialyse péritonéale

Définitions

- **Épuration extrarénale (dialyse)**
- **Traitement de suppléance**
- **Diffusion**
- **Convection, ultrafiltration**
- **Poids sec**
- **Fistule artérioveineuse**
- **Circuit d'hémodialyse**
- **Taux de réduction de l'urée (TRU)**
- **Kt/V**
- **Dialyse péritonéale (DP)**
- **DPCA**
- **DPA**
- **Ultrafiltration osmotique**
- **Péritonite**

Formules

- **Taux de réduction de l'urée** : TRU (%) = (urée avant − urée après) / urée avant × 100
- **Kt/V** : Kt/V = K (mL/min) × t (min) / V (mL)
- **Prise de poids interdialytique** : PPID (kg) = poids d'arrivée − poids sec
- **Volume à retirer par ultrafiltration** : volume (L) ≈ prise de poids (kg), car 1 kg d'eau ≈ 1 L
- **Glucose absorbé en DP** : glucose (g/j) = volume instillé (L) × concentration (g/L) × fraction...
- **Énergie du glucose du dialysat** : énergie (kcal) ≈ glucose absorbé (g) × 4 (valeur réglementaire
- **Concentration des solutions de DP** : g/L = % × 10

Valeurs repères

- **Début de la dialyse** : stade G5
- **Hémodialyse : rythme** : 3 séances de 4 h par semaine (≥ 12 h/semaine)
- **Débit sanguin** : 300 à 400 mL/min
- **Dialysat d'HD** : ≈ 500 mL/min à contre-courant
- **Urée pendant une séance** : baisse d'environ deux tiers
- **Intervalle interdialytique** : 44 h en semaine
- **TRU** : objectif ≥ 65 % (souvent ≥ 70 %)
- **Pertes en HD** : acides aminés ≈ 6 à 12 g par séance
- **Dialyse péritonéale** : ≈ 6 % des dialysés

34.3.2 Alimentation du dialysé et transplantation rénale

Définitions

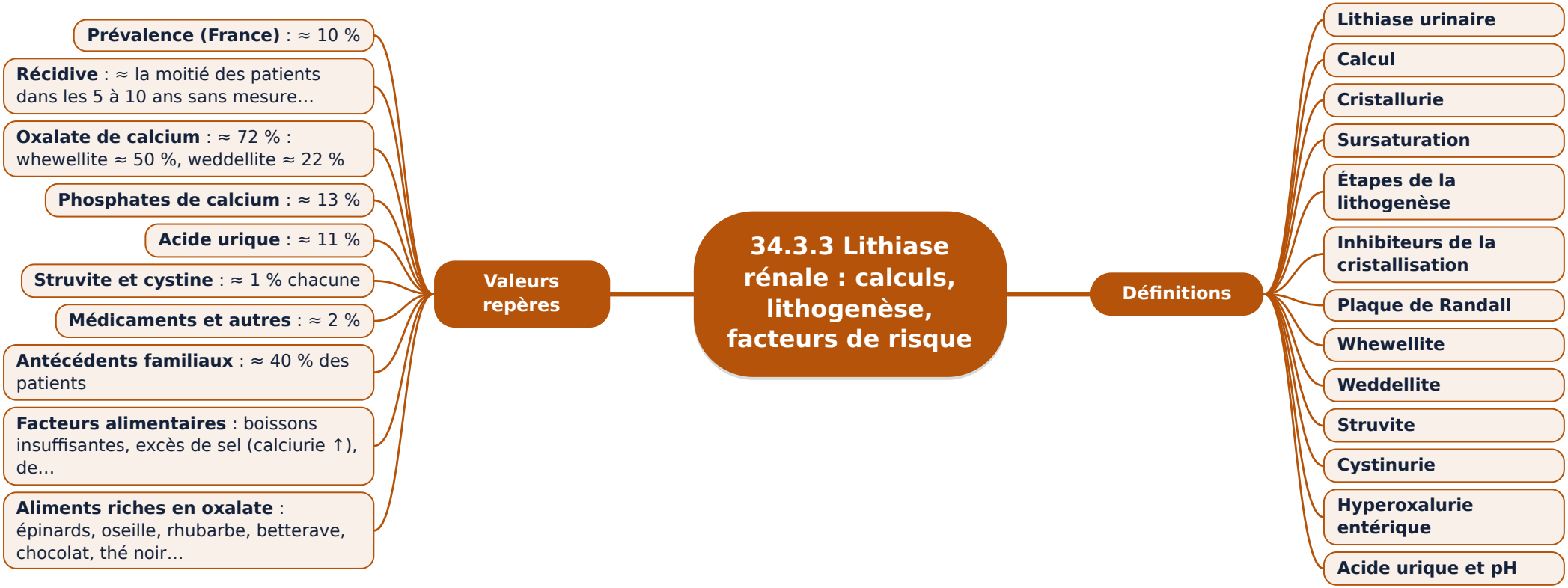
- **Ce qui change à l'entrée en dialyse**
- **Nutrition parentérale per-dialytique (NPPD)**
- **Transplantation rénale**
- **Rejet**
- **Diabète post-transplantation**
- **Pamplemousse et millepertuis**
- **Hygiène alimentaire du greffé**

Formules

- **Protéines du dialysé** : protéines (g/j) = 1,0 à 1,2 × poids sec (kg)
- **Ration de boissons en hémodialyse** : boissons (mL/j) = diurèse résiduelle des 24 h + ≈ 500 mL
- **Sodium → sel** : sel (g) = sodium (g) × 2,54

Valeurs repères

- **Énergie (HD et DP, KDOQI 2020)** : 25 à 35 kcal/kg de poids sec/j (glucose du dialysat compris…
- **Protéines (HD et DP)** : 1,0 à 1,2 g/kg/j, au moins la moitié de haute valeur…
- **Sodium en HD** : < 2 à 2,3 g/j (≈ 5 à 6 g de sel)
- **Prise de poids interdialytique visée** : < 2 à 2,5 kg (< 4 % du poids sec)
- **Potassium** : HD : restriction personnalisée (souvent 2 à 3 g/j) selon la…
- **Phosphore** : 800 à 1 000 mg/j + chélateurs au milieu des repas
- **Vitamines** : supplément en hydrosolubles (B1, B6, B9, C modérée)
- **Greffes rénales (Agence de la biomédecine)** : 3 525 en 2023
- **Après la greffe** : boissons ≈ 2 L/j les premiers mois


34.3.3 Lithiase rénale : calculs, lithogenèse, facteurs de risque
Valeurs repères
Prévalence (France) : ≈ 10 %
Récidive : ≈ la moitié des patients dans les 5 à 10 ans sans mesure...
Oxalate de calcium : ≈ 72 % : whewellite ≈ 50 %, weddellite ≈ 22 %
Phosphates de calcium : ≈ 13 %
Acide urique : ≈ 11 %
Struvite et cystine : ≈ 1 % chacune
Médicaments et autres : ≈ 2 %
Antécédents familiaux : ≈ 40 % des patients
Facteurs alimentaires : boissons insuffisantes, excès de sel (calciurie ↑), de...
Aliments riches en oxalate : épinards, oseille, rhubarbe, betterave, chocolat, thé noir...
Définitions
Lithiase urinaire
Calcul
Cristallurie
Sursaturation
Étapes de la lithogenèse
Inhibiteurs de la cristallisation
Plaque de Randall
Whewellite
Weddellite
Struvite
Cystinurie
Hyperoxalurie entérique
Acide urique et pH

34.3.3 Lithiase rénale : colique néphrétique, bilan, prévention

Définitions

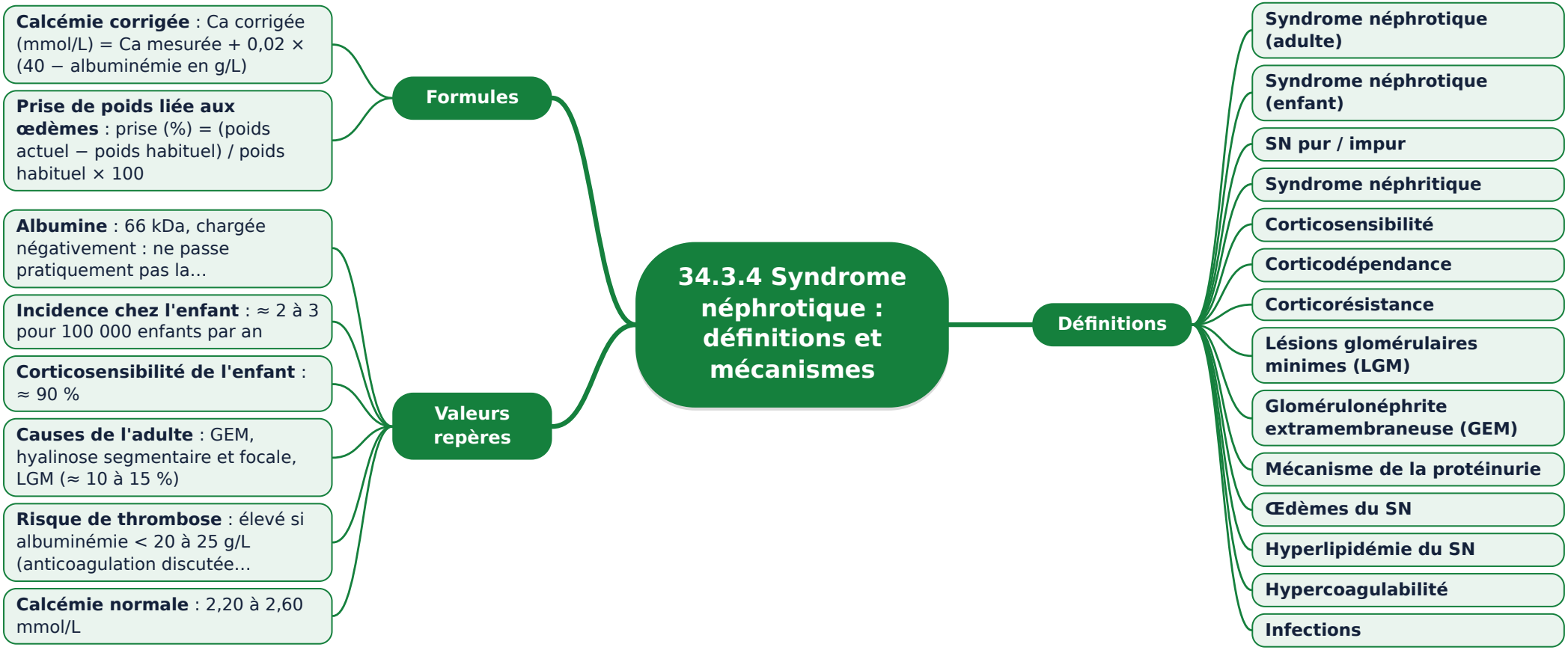
- Colique néphrétique
- Hydronéphrose
- Sites de blocage
- Mécanisme de la douleur
- Signes
- Colique néphrétique compliquée
- Examen de référence
- Traitements urologiques
- Analyse du calcul
- Formule de Maroni

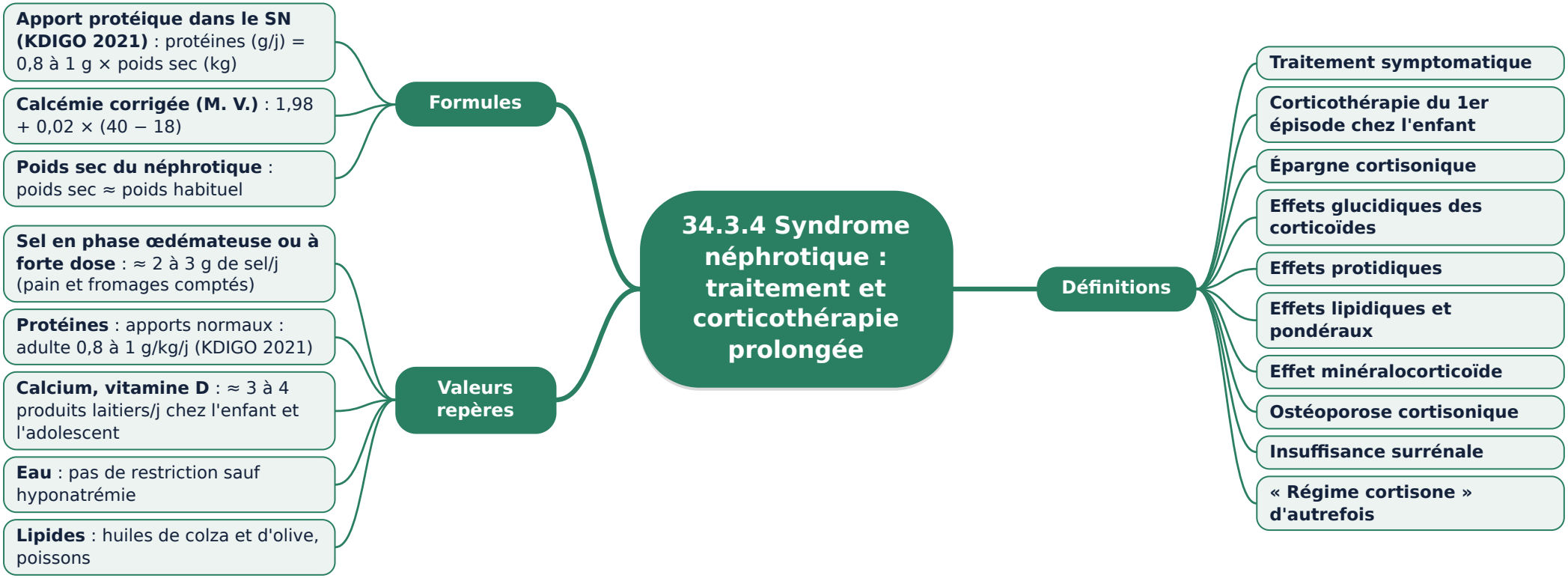
Formules

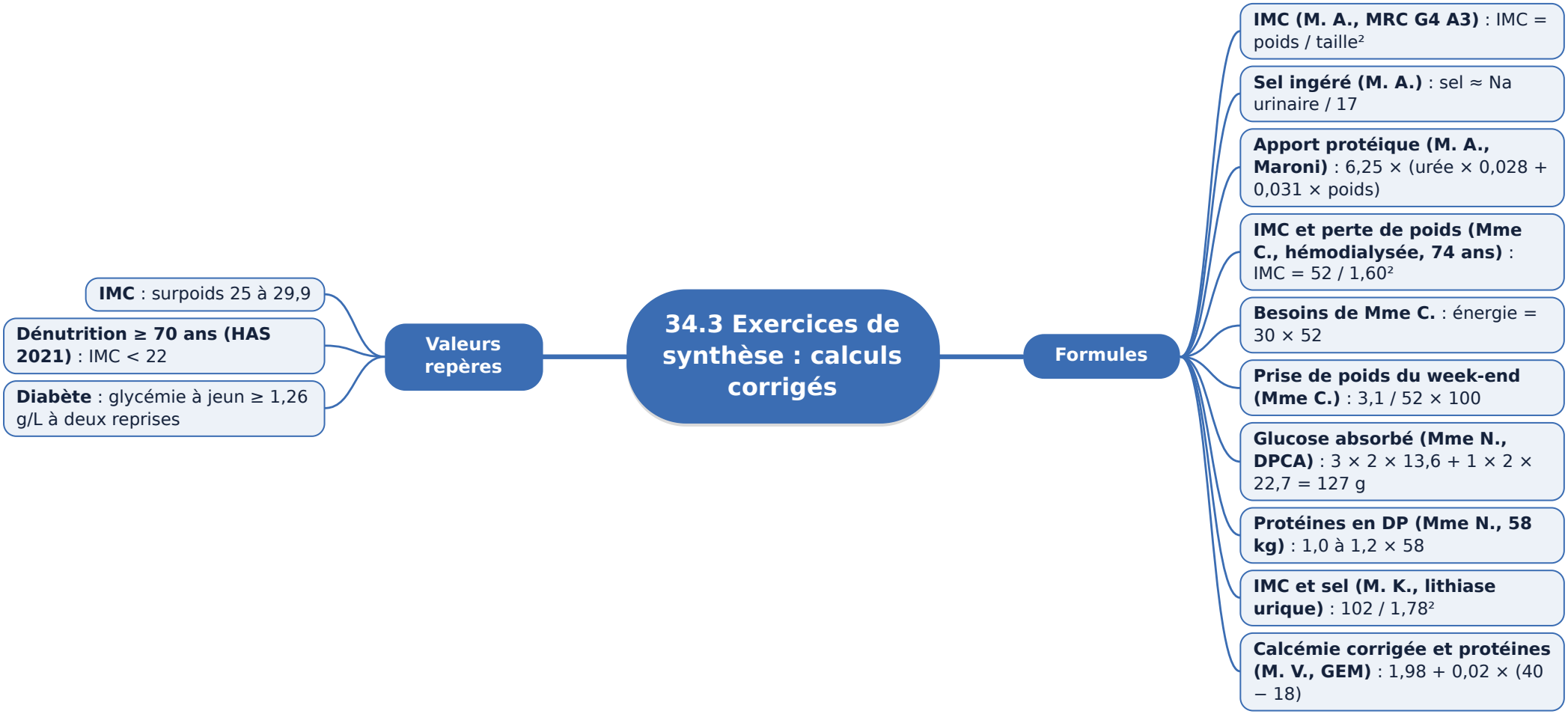
- **Sel ingéré** : sel (g/j) ≈ sodium urinaire des 24 h (mmol) / 17
- **Apport protéique (Maroni)** : protéines (g/j) ≈ 6,25 × [urée urinaire (mmol/24 h) × 0,028 + 0,031 × poids...
- **Seuil d'hypercalciurie** : seuil (mmol/j) = 0,1 × poids (kg)
- **Concentration urinaire** : concentration = quantité excrétée par jour / volume des urines

Valeurs repères

- **Expulsion spontanée** : calcul < 5 mm : le plus souvent en quelques jours à semaines
- **Diurèse** : > 2 L/24 h
- **Hypercalciurie** : > 0,1 mmol/kg/j (≈ 7,5 mmol/j chez l'homme, 6,2 chez la...
- **Hyperuricurie** : > 4,5 mmol/j environ
- **Hypocitraturie** : < 1,7 mmol/j environ
- **Natriurèse et sel** : 17 mmol de Na urinaire ≈ 1 g de sel ingéré
- **Mesures générales (CLAFU 2022)** : diurèse > 2 L/j (2 à 2,5 L de boissons réparties sur 24 h)
- **Lithiase urique** : alcaliniser : pH urinaire 6,5 à 7
- **Lithiase cystinique** : diurèse ≥ 3 L/j
- **Whewellite (hyperoxalurie)** : limiter les aliments riches en oxalate


34.3.4 Syndrome néphrotique : définitions et mécanismes
Définitions
Syndrome néphrotique (adulte)
Syndrome néphrotique (enfant)
SN pur / impur
Syndrome néphritique
Corticosensibilité
Corticodépendance
Corticorésistance
Lésions glomérulaires minimes (LGM)
Glomérulonéphrite extramembraneuse (GEM)
Mécanisme de la protéinurie
Œdèmes du SN
Hyperlipidémie du SN
Hypercoagulabilité
Infections
Valeurs repères
Albumine : 66 kDa, chargée négativement : ne passe pratiquement pas la...
Incidence chez l'enfant : ≈ 2 à 3 pour 100 000 enfants par an
Corticosensibilité de l'enfant : ≈ 90 %
Causes de l'adulte : GEM, hyalinose segmentaire et focale, LGM (≈ 10 à 15 %)
Risque de thrombose : élevé si albuminémie < 20 à 25 g/L (anticoagulation discutée...
Calcémie normale : 2,20 à 2,60 mmol/L
Formules
Calcémie corrigée : Ca corrigée (mmol/L) = Ca mesurée + 0,02 × (40 − albuminémie en g/L)
Prise de poids liée aux œdèmes : prise (%) = (poids actuel − poids habituel) / poids habituel × 100


34.3.4 Syndrome néphrotique : traitement et corticothérapie prolongée
Formules
Apport protéique dans le SN (KDIGO 2021) : protéines (g/j) = 0,8 à 1 g × poids sec (kg)
Calcémie corrigée (M. V.) : 1,98 + 0,02 × (40 − 18)
Poids sec du néphrotique : poids sec ≈ poids habituel
Valeurs repères
Sel en phase œdémateuse ou à forte dose : ≈ 2 à 3 g de sel/j (pain et fromages comptés)
Protéines : apports normaux : adulte 0,8 à 1 g/kg/j (KDIGO 2021)
Calcium, vitamine D : ≈ 3 à 4 produits laitiers/j chez l'enfant et l'adolescent
Eau : pas de restriction sauf hyponatrémie
Lipides : huiles de colza et d'olive, poissons
Définitions
Traitement symptomatique
Corticothérapie du 1er épisode chez l'enfant
Épargne cortisonique
Effets glucidiques des corticoïdes
Effets protidiques
Effets lipidiques et pondéraux
Effet minéralocorticoïde
Ostéoporose cortisonique
Insuffisance surrénale
« Régime cortisone » d'autrefois


34.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés
Valeurs repères
IMC : surpoids 25 à 29,9
Dénutrition ≥ 70 ans (HAS 2021) : IMC < 22
Diabète : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à deux reprises
Formules
IMC (M. A., MRC G4 A3) : IMC = poids / taille²
Sel ingéré (M. A.) : sel ≈ Na urinaire / 17
Apport protéique (M. A., Maroni) : 6,25 × (urée × 0,028 + 0,031 × poids)
IMC et perte de poids (Mme C., hémodialysée, 74 ans) : IMC = 52 / 1,60²
Besoins de Mme C. : énergie = 30 × 52
Prise de poids du week-end (Mme C.) : 3,1 / 52 × 100
Glucose absorbé (Mme N., DPCA) : 3 × 2 × 13,6 + 1 × 2 × 22,7 = 127 g
Protéines en DP (Mme N., 58 kg) : 1,0 à 1,2 × 58
IMC et sel (M. K., lithiase urique) : 102 / 1,78²
Calcémie corrigée et protéines (M. V., GEM) : 1,98 + 0,02 × (40 − 18)

34.4.1 à 34.4.3 Potassium, phosphore caché et sel

Définitions

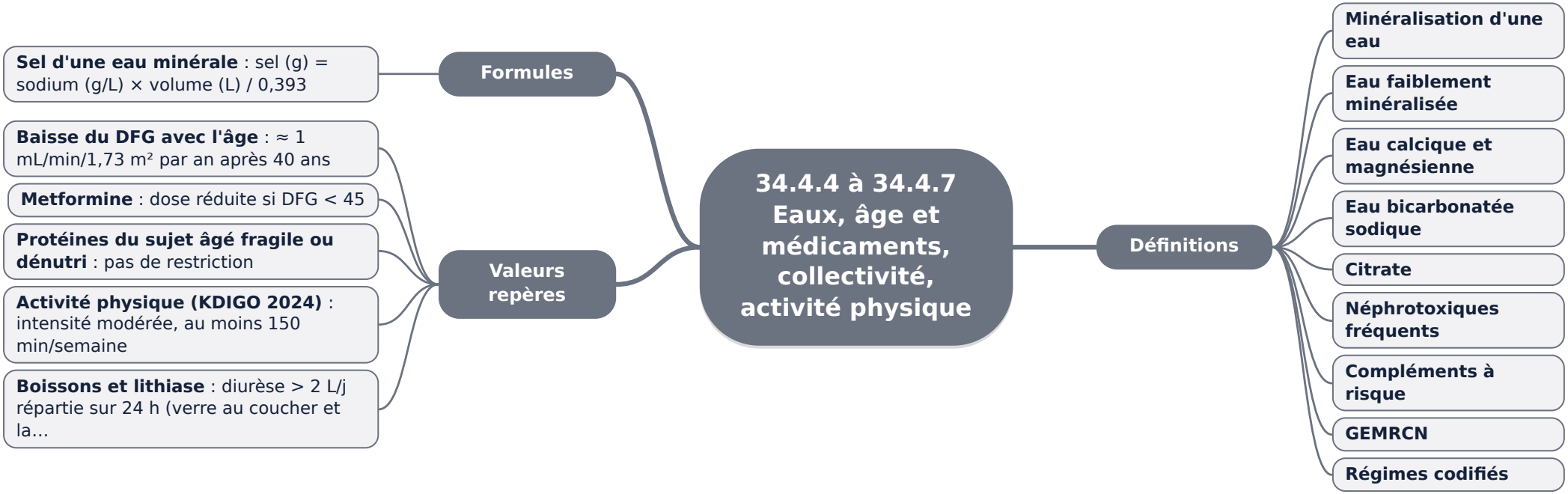
- **Potassium alimentaire**
- **Causes non alimentaires d'hyperkaliémie**
- **Phosphore organique animal**
- **Phosphore organique végétal**
- **Phosphore des additifs**
- **Rapport phosphore/protéines**
- **Chélateurs du phosphore**
- **Sources de sel**

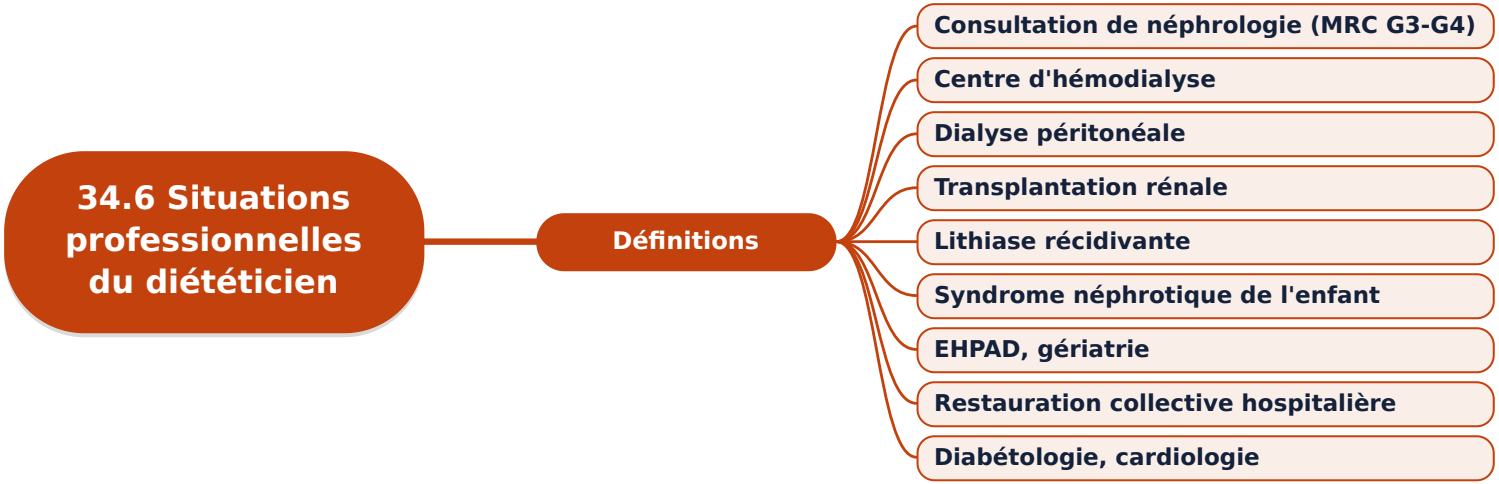
Formules

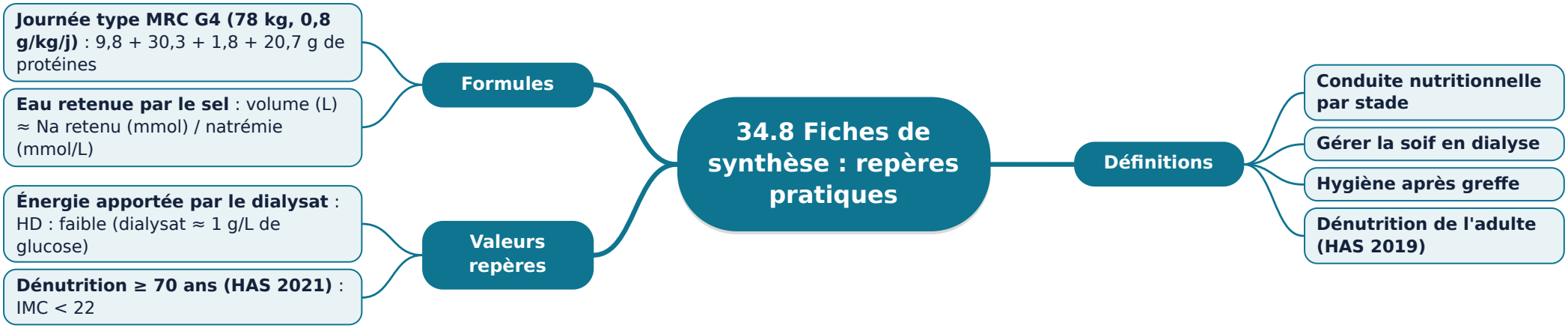
- **Potassium d'une journée** : K (mg) = somme des apports
- **Effet de la cuisson à grande eau** : K restant = K initial × (1 − fraction perdue)
- **Phosphore absorbé** : P absorbé (mg) = P ingéré (mg) × coefficient d'absorption
- **Sel ↔ sodium** : sel (g) = Na (mmol) / 17 = Na (mg) / 393
- **Sel ingéré d'après la natriurèse** : sel (g/j) ≈ natriurèse (mmol/24 h) / 17
- **Sel d'un aliment** : sel (g) = portion (g) × teneur (g/100 g) / 100

Valeurs repères

- **Excrétion du potassium (sujet sain)** : ≈ 90 % par les reins, le reste par le côlon
- **Potassium : alimentation habituelle** : 3 à 4 g/j
- **Cuisson à grande eau (épluché, coupé, trempé)** : − 30 à 50 % de potassium
- **Hyperkaliémie urgente** : > 6,0 mmol/L ou anomalies de l'ECG
- **Potassium pour 100 g** : abricots, figues, dattes secs 700 à 1 100 mg
- **Sels de régime** : chlorure de potassium (> 40 % de potassium)…
- **Rapport phosphore/protéines** : blanc d'œuf ≈ 1 à 2 mg/g
- **Consommation de sel en France** : hommes 8 à 9 g/j
- **Repères de sel** : OMS : < 5 g/j (< 2 g de Na)
- **Sel des portions** : 1/4 de baguette ≈ 0,9 g


34.4.4 à 34.4.7 Eaux, âge et médicaments, collectivité, activité physique
Définitions
Minéralisation d'une eau
Eau faiblement minéralisée
Eau calcique et magnésienne
Eau bicarbonatée sodique
Citrate
Néphrotoxiques fréquents
Compléments à risque
GEMRCN
Régimes codifiés
Formules
Sel d'une eau minérale : sel (g) = sodium (g/L) × volume (L) / 0,393
Valeurs repères
Baisse du DFG avec l'âge : ≈ 1 mL/min/1,73 m² par an après 40 ans
Metformine : dose réduite si DFG < 45
Protéines du sujet âgé fragile ou dénutri : pas de restriction
Activité physique (KDIGO 2024) : intensité modérée, au moins 150 min/semaine
Boissons et lithiase : diurèse > 2 L/j répartie sur 24 h (verre au coucher et la...


34.6 Situations professionnelles du diététicien
Définitions
Consultation de néphrologie (MRC G3-G4)
Centre d'hémodialyse
Dialyse péritonéale
Transplantation rénale
Lithiase récidivante
Syndrome néphrotique de l'enfant
EHPAD, gériatrie
Restauration collective hospitalière
Diabétologie, cardiologie


34.8 Fiches de synthèse : repères pratiques
Formules
Journée type MRC G4 (78 kg, 0,8 g/kg/j) : 9,8 + 30,3 + 1,8 + 20,7 g de protéines
Eau retenue par le sel : volume (L) ≈ Na retenu (mmol) / natrémie (mmol/L)
Valeurs repères
Énergie apportée par le dialysat : HD : faible (dialysat ≈ 1 g/L de glucose)
Dénutrition ≥ 70 ans (HAS 2021) : IMC < 22
Définitions
Conduite nutritionnelle par stade
Gérer la soif en dialyse
Hygiène après greffe
Dénutrition de l'adulte (HAS 2019)

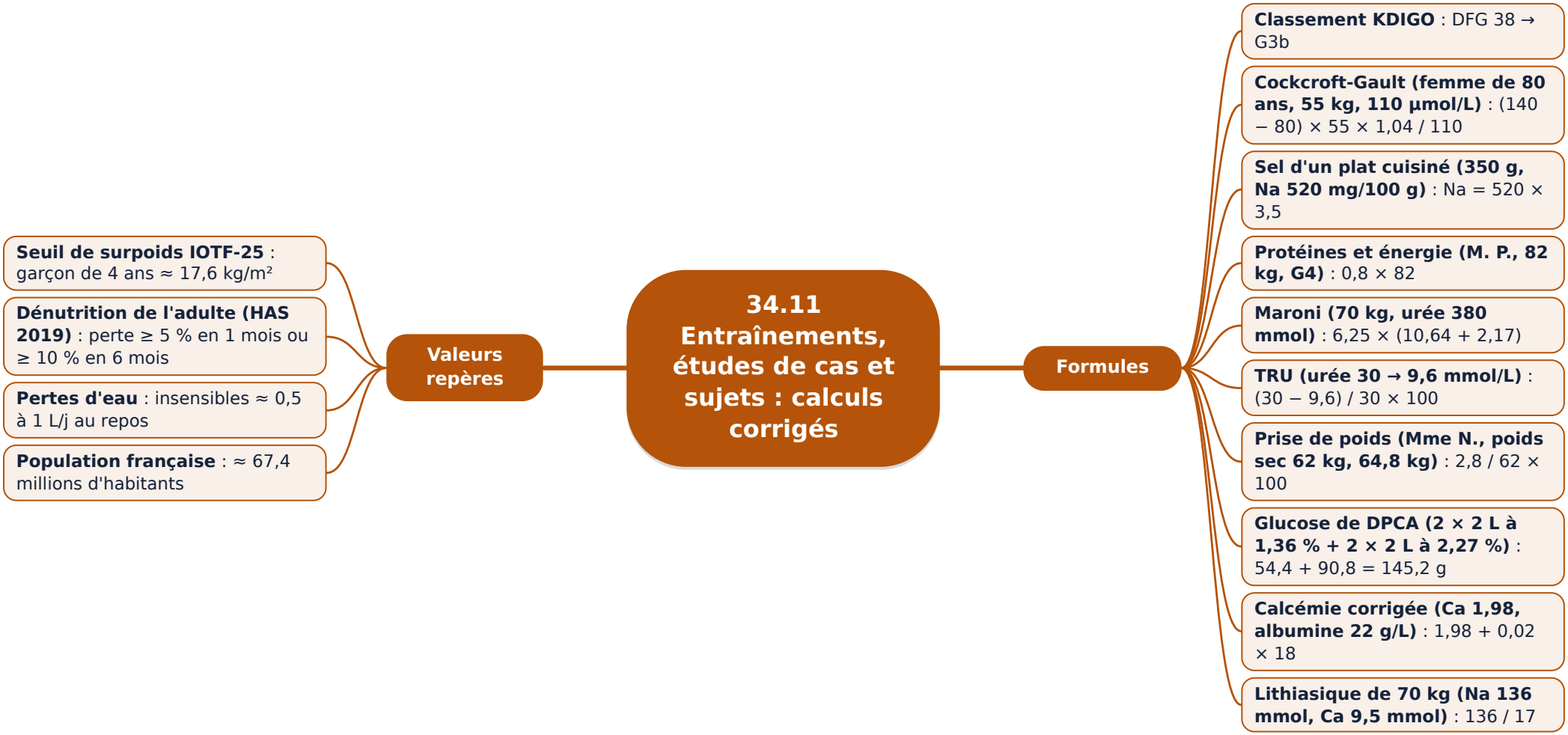
34.9 Unités, conversions et relations

Valeurs repères

- **Créatininémie** : ≈ 60 à 110 µmol/L (selon le sexe et la masse musculaire)
- **Urée sanguine** : 2,5 à 7,5 mmol/L
- **Rapport albumine/créatinine urinaire** : < 3 mg/mmol (< 30 mg/g)
- **Unité du DFG** : mL/min/1,73 m² (indexé)

Formules

- **Sodium et sel** : 1 g de sel = 393 mg de Na = 17 mmol (17,1)
- **Sel ingéré** : sel (g/j) ≈ natriurèse des 24 h (mmol) / 17
- **Potassium** : 1 mmol = 39,1 mg
- **Phosphore** : 1 mmol = 31 mg
- **Calcium** : 1 mmol = 40 mg
- **Créatinine** : 1 mg/dL = 88,4 µmol/L
- **Urée** : 1 mmol d'urée = 60 mg d'urée = 28 mg d'azote
- **Clairance de Cockcroft-Gault** : (140 − âge) × poids × k / créatininémie (µmol/L)
- **DFG désindexé** : DFG indexé × surface corporelle / 1,73
- **Apport protéique (Maroni)** : 6,25 × [urée urinaire des 24 h (mmol) × 0,028 + 0,031 × poids (kg)]


34.11 Entraînements, études de cas et sujets : calculs corrigés
Valeurs repères
Seuil de surpoids IOTF-25 : garçon de 4 ans ≈ 17,6 kg/m²
Dénutrition de l'adulte (HAS 2019) : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois
Pertes d'eau : insensibles ≈ 0,5 à 1 L/j au repos
Population française : ≈ 67,4 millions d'habitants
Formules
Classement KDIGO : DFG 38 → G3b
Cockcroft-Gault (femme de 80 ans, 55 kg, 110 µmol/L) : (140 − 80) × 55 × 1,04 / 110
Sel d'un plat cuisiné (350 g, Na 520 mg/100 g) : Na = 520 × 3,5
Protéines et énergie (M. P., 82 kg, G4) : 0,8 × 82
Maroni (70 kg, urée 380 mmol) : 6,25 × (10,64 + 2,17)
TRU (urée 30 → 9,6 mmol/L) : (30 − 9,6) / 30 × 100
Prise de poids (Mme N., poids sec 62 kg, 64,8 kg) : 2,8 / 62 × 100
Glucose de DPCA (2 × 2 L à 1,36 % + 2 × 2 L à 2,27 %) : 54,4 + 90,8 = 145,2 g
Calcémie corrigée (Ca 1,98, albumine 22 g/L) : 1,98 + 0,02 × 18
Lithiasique de 70 kg (Na 136 mmol, Ca 9,5 mmol) : 136 / 17

Les pièges

- « Un patient ayant fait un calcul d'oxalate de calcium doit supprimer les laitages. » → faux : Un apport calcique de 800 à 1 000 mg/j diminue l'absorption de l'oxalate ; la suppression augmente l'oxalurie.
- « Pendant une colique néphrétique, il faut faire boire abondamment pour « pousser » le calcul. » → faux : L'hyperhydratation augmente la pression dans les cavités et la douleur ; boissons selon la soif.
- « L'alcalinisation des urines est utile pour tous les calculs. » → faux : Elle est utile pour l'acide urique et la cystine ; elle favorise les calculs phosphocalciques.
- « Dans le syndrome néphrotique, un régime hyperprotidique corrige l'hypoalbuminémie. » → faux : Il augmente la protéinurie sans relever l'albuminémie : 0,8 à 1 g/kg/j.
- « Une calcémie totale basse dans le syndrome néphrotique traduit toujours une hypocalcémie vraie. » → faux : La baisse de l'albumine diminue le calcium lié ; on calcule la calcémie corrigée.
- « Le poids d'un patient œdémateux reflète bien son état nutritionnel. » → faux : Les œdèmes masquent la perte de masse maigre ; on raisonne sur le poids sec.
- « Une créatininémie normale exclut une maladie rénale chronique. » → faux : Elle ne monte qu'après la perte d'environ la moitié des néphrons ; un DFG à 60-89 avec albuminurie est une MRC (stade G2 A2).
- « Un régime hyperprotidique protège le rein du patient en MRC. » → faux : Il augmente l'hyperfiltration : KDIGO 2024 recommande 0,8 g/kg/j et de ne pas dépasser 1,3 g/kg/j.
- « Un sel de régime au chlorure de potassium est un bon substitut du sel chez l'insuffisant rénal. » → faux : Il expose à l'hyperkaliémie ; on utilise herbes, épices, aromates.
- « Les chélateurs du phosphore doivent être pris à jeun. » → faux : Ils se prennent au milieu des repas pour fixer le phosphate alimentaire.
- « L'hyperphosphatémie est la première anomalie des troubles minéraux et osseux de la MRC. » → faux : Le FGF23 augmente dès G2-G3 et maintient la phosphorémie normale ; l'hyperphosphatémie apparaît aux stades G4-G5.
- « Après une greffe rénale réussie, le patient garde les restrictions de la dialyse. » → faux : Le greffon fonctionne : alimentation équilibrée, sel modéré, prévention du surpoids, hygiène alimentaire.